

Lombalgies

Drapeaux rouges lombalgies – métastases :

- ATCD de cancer (**sein, poumon, prostate, rein, thyroïde**)
- Âge > 50 ans
- **Perte pondérale**
- **Baisse de l'état général**
- Absence d'amélioration au repos ou en position couchée
- Douleur localisée à la palpation
- Syndrome de la queue de cheval ou de compression radiculaire

Drapeaux rouges lombalgies – spondylodiscite :

- **Toxicomanie iv**
- **Immunodéficience**
- Plaie à proximité
- Baisse de l'état général
- **Symptômes – signes d'endocardite (fièvre, tachycardie, frisson, dyspnée, toux, nouveau souffle, faiblesse, perte poids, sudation nocturnes)**
- Douleur en sonnette (= douleur brutale à 1 loca)
- **Fièvre**
- Douleur inflammatoire (au repos, nocturne, diminue lors d'activité)
- Raideur rachidienne

Drapeaux rouges lombalgies et anévrysme de l'AA :

- HTA
- > 60 ans
- **Douleur abdominale**
- **Masse abdominale pulsatile**
- **Souffles fémoraux**
- Troubles vasculaires des MI
- Syphilis
- Sy. De Marfan

Drapeaux rouges et fracture vertébrale :

- > 50 ans
- **Ostéoporose connue**
- **Corticothérapie longue durée**
- Traumatisme
- Déformation du rachis
- Douleur localisée à la palpation sy de la queue de cheval ou de compression radiculaire (rare)

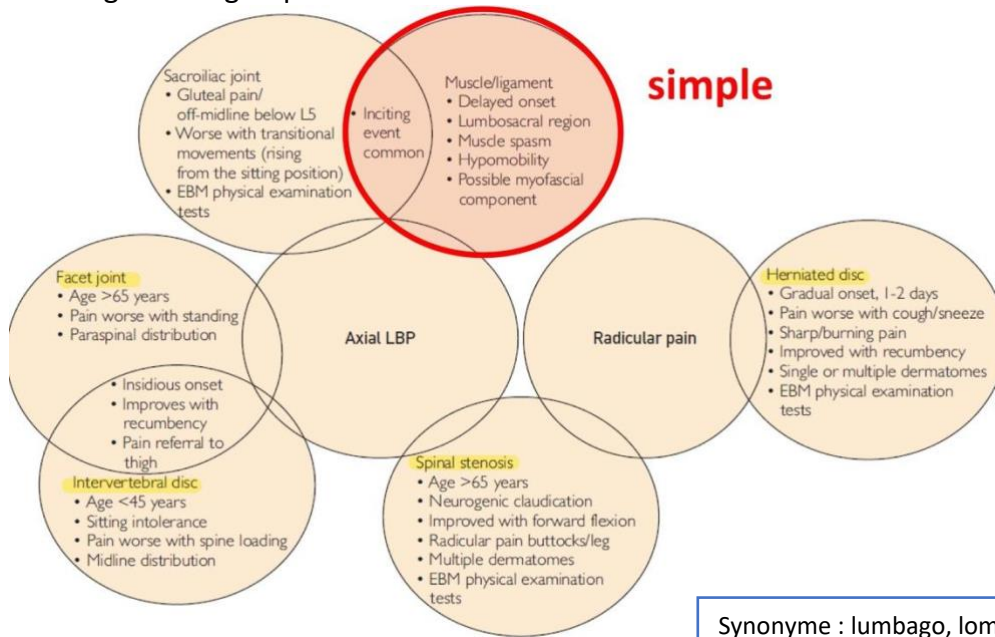
Drapeaux rouges lombalgie et syndrome de la queue de cheval :

- Déficit moteur
- Déficit du réflexe achilléen
- Déficit sensitif selon dermatome
- Troubles sphinctériens : globe urinaire, hypotonie sphinctérienne anale au TR.

Examen clinique

1. Marche
 - a. Normal
 - b. Talon
 - c. Pointe
2. Romberg
3. Inspection
 - a. Latéralement (LCL)
 - b. Postérieurement (scoliose)
 - c. Regarder colonne quand se penche en avant
4. Palpation
 - a. Épine iliaque □ chez hauteur
 - b. L4-L5 □ articulation sacro-iliaque (même ligne qu'épine)
 - c. Muscle paravertébraux
5. Percussion
 - a. Vertèbres
6. Examen
 - a. Cervicale
 - Dire oui de la tête – dire non
 - Toucher l'épaule avec l'oreille
 - b. Lombaire (DEBOUT)
 - Se pencher en avant
 - Se pencher un peu en arrière
 - Se pencher de chaque côté
 - **Test de Schober** : mettre le pouce sur L5 et mettre l'index sur le processus épineux 10 cm plus haut □ patient se penche en avant □ 15 cm entre les doigts si normal
 - **Signe de la sonnette** : appuyer fort sur la vertèbre □ signe positif si patient se crispe □ suspicion de radiculopathie et décharge latérale à la jambe jusqu'à derrière le genou
 - c. Thoracique
 - Patients ASSIS □ tourner les épaules les bras croisés
 - d. COUCHER
 - **Test de lasègue L5-S1** : test + si décharge dans la jambe entre 40° et 60°
 - **Test de Bragard** : = test de lasègue avec dorsiflexion
 - **Lasègue inversé L3-L4**
7. Examen neuro ciblé
 - a. Sensibilité
 - b. Motricité
 - c. Réflexe
 - d. Sphincter
8. Toucher rectal

Lombalgie étiologie spinale :



Lombalgie aiguë simple

Symptômes et signes :

- Localisée en lombaire diffuse
- Début rapide après un effort
- Irradiation lombaire (avec composante de sciatalgie)
- Intensité légère à sévère
- Douleur mécanique (améliorée au repos, augmentée au mouvement)
- Pas de symptômes associés
- Pas de troubles sphinctériens
- ATCD de lombalgie aiguë
- Examen neurologique normal, éventuellement lasèque +

Prise en charge :

- Rassurer, expliquer la nature bénigne de l'affection tout en prenant au sérieux les plaintes □ anamnèse et status permettent d'exclure une maladie grave
- Pas besoin d'imagerie
- Antalgie :
 - **AINS** (ibuprofène)
 - Ev. Tramadol si AINS inefficace mais pas plus de 5 jours
 - Appliquer du froid / de la chaleur
- Médecine manuelle – ostéopathie
- Acupuncture
- Relaxation
- Physiothérapie post phase aiguë

Synonyme : lumbago, lombalgie, lombosciatalgie, syndrome lombo-vertébral, syndrome radiculaire irritatif non déficitaire

Résumé :

